HagaZiekenhuis

Carpaal tunnel syndroom (CTS) Neurochirurgie

Het carpaal tunnel syndroom (CTS) is een aandoening waarbij de zenuw in de carpaal tunnel beklemd is geraakt (zie tekening 1). Het ontstaat door zwelling van weefsel rondom de buigpezen. Hierdoor krijgt u een doof of prikkelend gevoel en pijn in de arm, hand en vingers.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is meestal niet te achterhalen. CTS kan ontstaan:

- als u lange tijd dezelfde beweging maakt (over-use syndrome).
- door een peesontsteking. Hierbij zwelt het omhulsel van de pezen op. Daardoor neemt de druk op de zenuw in de carpaal tunnel toe.
- door verstuikingen, botbreuken en gewrichtsontsteking (arthritis). Deze kunnen ook tot vernauwing van de tunnel leiden.
- door reuma, suikerziekte of een traag werkende schildklier.
- tijdens zwangerschap. Een zwangere vrouw houdt vaak veel vocht vast. Hierdoor kan een zwelling in de tunnel ontstaan met bijbehorende klachten. Meestal gaat het carpaal tunnel syndroom vanzelf over na de zwangerschap.

De klachten treden meestal 's nachts op. Bij sommige activiteiten gebruikt u de hand in een bepaalde stand. Denk bijvoorbeeld aan autorijden, fietsen of de krant lezen. Ook deze activiteiten kunnen klachten veroorzaken.

Wat zijn de klachten?

Deze kunnen voor ieder mens verschillen. Zo kunt u last hebben van:

- een doof of tintelend gevoel in één of beide handen. Dit komt vooral voor in de handpalm, de duim, wijs-, middel- en ringvinger; in de pink nooit.
- krachtverlies van uw hand en gevoelsstoornis in de vingertoppen. Daardoor laat u makkelijk iets vallen.

een minder goed werkende hand en minder pijn. Dit gebeurt vaak als u al langer last heeft van deze aandoening. Dan duurt de druk op de zenuw ook al langer. In het ergste geval kan blijvend gevoelsverlies optreden. Ook de spieren van de muis van de duim kunnen krimpen (zie tekening 2).

Diagnose

Voor het stellen van de juiste diagnose is het belangrijk dat u uw arts goed informeert. Vertel uw arts over het gebruik van uw hand, over uw beroep, over mogelijk eerdere schade aan uw hand of pols en over uw klachten. Soms moet er uitgebreider onderzoek worden gedaan. Dat kan zijn:

- een zenuwgeleidingsonderzoek en een spierfunctieonderzoek (electromyografie). Een neuroloog voert dit onderzoek uit. Doel van het onderzoek is er zeker van te zijn dat de zenuw niet op een andere plaats in de knel zit.
- een röntgenfoto om een andere oorzaak uit te sluiten, zoals een botbreuk of gewrichtsontsteking.
- een bloedonderzoek. Als uw arts vermoedt dat een andere ziekte (bijvoorbeeld reuma) een rol speelt in het ontstaan van het carpaal tunnel syndroom.

Behandeling

Wanneer de diagnose ‘carpaal tunnel syndroom’ is vastgesteld, zijn er twee mogelijkheden voor behandeling.

Behandeling zonder operatie

Afhankelijk van de oorzaak adviseert uw arts één of meer behandelingen. Dat kan zijn:

- het aanpassen van sommige activiteiten, met als doel het verminderen van de belasting van uw hand en pols. De beknelde zenuw krijgt op die manier weer ruimte.
- het recht houden van de pols. Daardoor kan de zwelling afnemen en krijgt de zenuw weer ruimte.
- het dragen van een polsspalk tijdens de nacht kan uw klachten verminderen en uw nachtrust verbeteren.
- een injectie met een ontstekingsremmer.

Een operatie

Blijven de klachten ernstig of gaan ze niet over dan kan een operatie nodig zijn.

Doel van de operatie

Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel wijder. Daardoor komt de zenuw uit zijn beklemming. Als het nodig is, maakt de arts ook de vliezen rondom de pezen schoon (synovectomie).

Voorbereiding voor de operatie

- Als u overgevoelig bent voor bijvoorbeeld pleisters of jodium moet u dit vóór de ingreep melden.
- Ook wanneer u medicijnen gebruikt, moet u dit vooraf melden. Dit geldt vooral voor bloed verdunnende middelen. Voor de arts is het belangrijk te weten dat u deze gebruikt. U hoeft niet te stoppen met de bloedverdunners.
- U mag vóór en na de behandeling gewoon eten en drinken.
- Wij vragen u thuis eventuele nagellak en/of sieraden te verwijderen.
- Voor uw eigen comfort raden wij u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Zelfstandige Behandelkamers. Het kan voorkomen dat het operatieschema iets uitloopt. Sommige behandelingen kunnen langer duren dan verwacht. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Een operatieassistent(e) komt u ophalen en brengt u naar de kleedruimte van een operatiekamer. De assistent(e) vertelt u òf en welk kledingstuk u uit moet doen. Dit hangt af van de plek van de operatie.

Om de operatiekamers zo schoon mogelijk te houden, krijgt u hoesjes over uw schoenen.

De operatie

De operatie duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt een plaatselijke verdoving in de hand. Bij een plaatselijke verdoving wordt soms korte tijd een bloeddrukmeterband om uw bovenarm gelegd en opgepompt. Daarna wordt de hand gedesinfecteerd en begint de arts met de operatie. De arts snijdt de peesplaat aan de handpalmzijde in. Deze peesplaat vormt het ‘dak’ van de tunnel, (zie tekening 3). De tunnel wordt zo wijder en de zenuw komt uit zijn beklemming.

Om infectie te voorkomen, wordt uw lichaam voor een deel afgedekt met steriele doeken. Laat u zich niet afschrikken door de operatiekleding van de medewerkers. Zij dragen deze kleding om u tegen infecties te beschermen.

Na de operatie

- U krijgt een mitella om. Deze draagt u één dag. Bent u geopereerd aan de elleboog? Dan draagt u de mitella twee dagen. ’s Nachts doet u de mitella af.
- Om nabloeden te voorkomen heeft u een drukverband gekregen. Na 2 dagen mag u zelf het verband verwijderen. Hierna mag de hand nat worden, mag u douchen en de wond onder de kraan afspoelen. Dep de wond droog met een schone handdoek.
- Daarna brengt u een schoon verband aan. Dit kunt u regelmatig en zo nodig vervangen. Dit verband kunt u zelf kopen bij uw apotheek of drogist.
- Houd uw hand goed hoog. Leg de hand bij het slapen gaan op een kussen, zodat de pols hoger ligt dan de elleboog.
- De verdoving is na een paar uur uitgewerkt. U kunt napijn krijgen. Om dit te verminderen mag u na de operatie Paracetamol innemen. U mag 4 keer per dag 1000 mg. Paracetamol slikken.
- De pijn als gevolg van de ingreep neemt meestal snel af. Het littekengebied kan nog wel enkele weken of maanden gevoelig zijn (wondpijn).
- De tintelingen 's nachts nemen snel af.
- Het terugkeren van het gevoel kan soms maanden duren. Het kan ook lange tijd duren voordat de kracht in uw hand en pols weer normaal is.
- Soms houdt u na de operatie klachten.
- Wanneer u de pols na de operatie weer zwaar belast, kan het syndroom terugkeren.

U mag **niet** zwemmen, in de sauna, afwassen en/of vies water gebruiken als u nog hechtingen heeft. Als u het prettig vindt, kunt u de wond afdekken met een **papieren** pleister en eventueel kunt u het drukverband langer dan 2 dagen laten zitten en/of vervangen.

14 dagen na de operatie krijgt u van de polikliniek Neurochirurgie een controle afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Het is belangrijk om direct na de operatie oefeningen met uw vingers te doen. Dit kan ook als u nog verband heeft.

- Maak een lichte vuist en strek de vingers weer.
- Doe dit elk uur 5 keer.

Gebruik de hand tot aan de controle afspraak alleen bij lichte activiteiten en probeer bewegingen vanuit de pols te voorkomen. U merkt dat de kracht in uw hand na de operatie minder is. Het litteken kan lange tijd gevoelig zijn. Dit is normaal na deze operatie. De klachten worden steeds minder.

Attentie: als u ernstige pijnklachten met zwelling heeft, of uw hand verkleurt, moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis:

- Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (070) 210 2040
- ’s Nachts en in het weekend via telefoonnummer: (070) 210 0000. U vraagt naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). De SEH neemt als het nodig is contact op met de neurochirurg.

Meer informatie vindt u in de folder Instructies na een poliklinische behandeling

Beperkingen na de operatie

Het duurt ongeveer twee tot vier weken voordat het dak van de tunnel is genezen.

In die tijd mag u de hand minder belasten. Wanneer u weer mag gaan werken hangt sterk af van uw werkzaamheden; huishoudelijk, kantoor, enzovoorts. Wij raden u af de eerste twee weken na de operatie auto te rijden en/of te fietsen.

Verhinderd

Kunt u niet op de afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. De operatieplanners kunnen hier dan rekening mee houden. U kunt zich afmelden bij het secretariaat van het specialisme waar u in behandeling bent. Het telefoonnummer hiervan staat op uw afsprakenbrief.

Ten slotte

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

581120052025